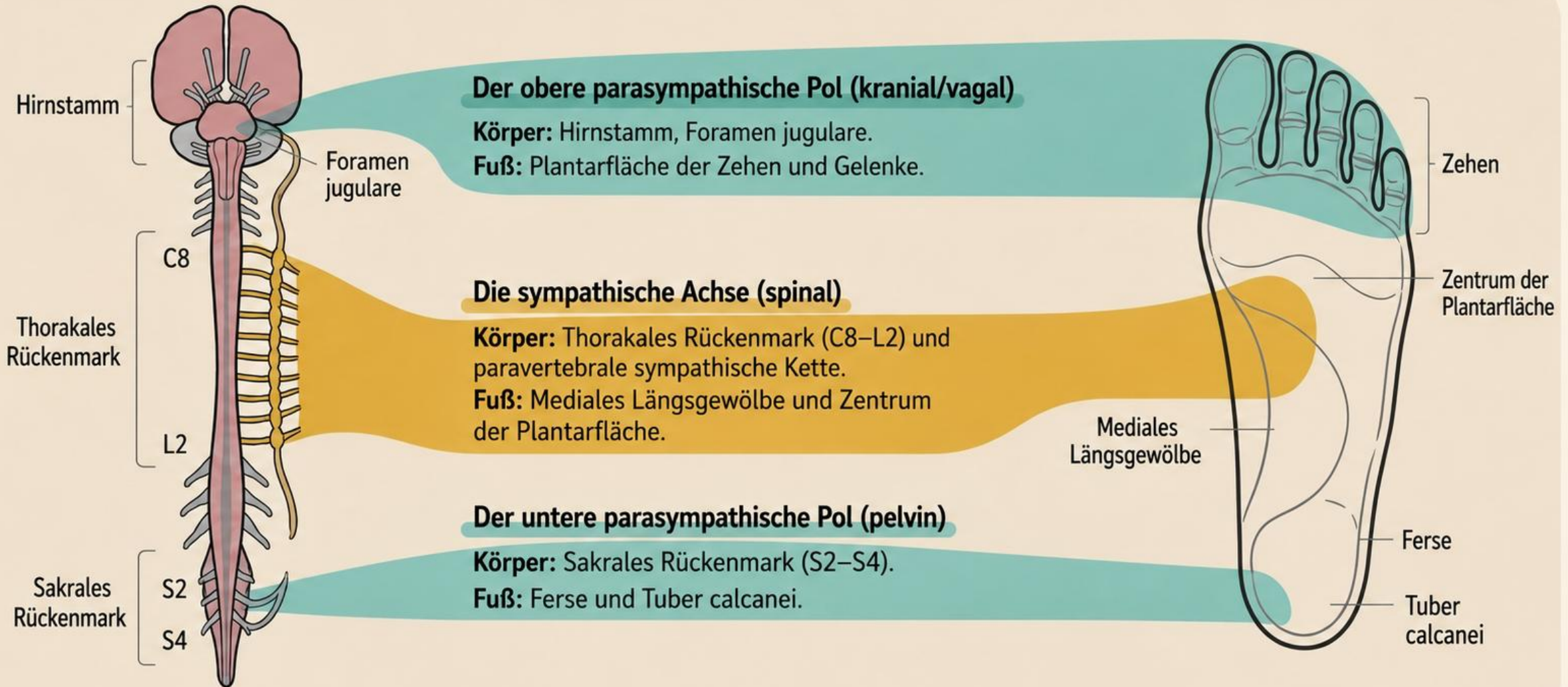


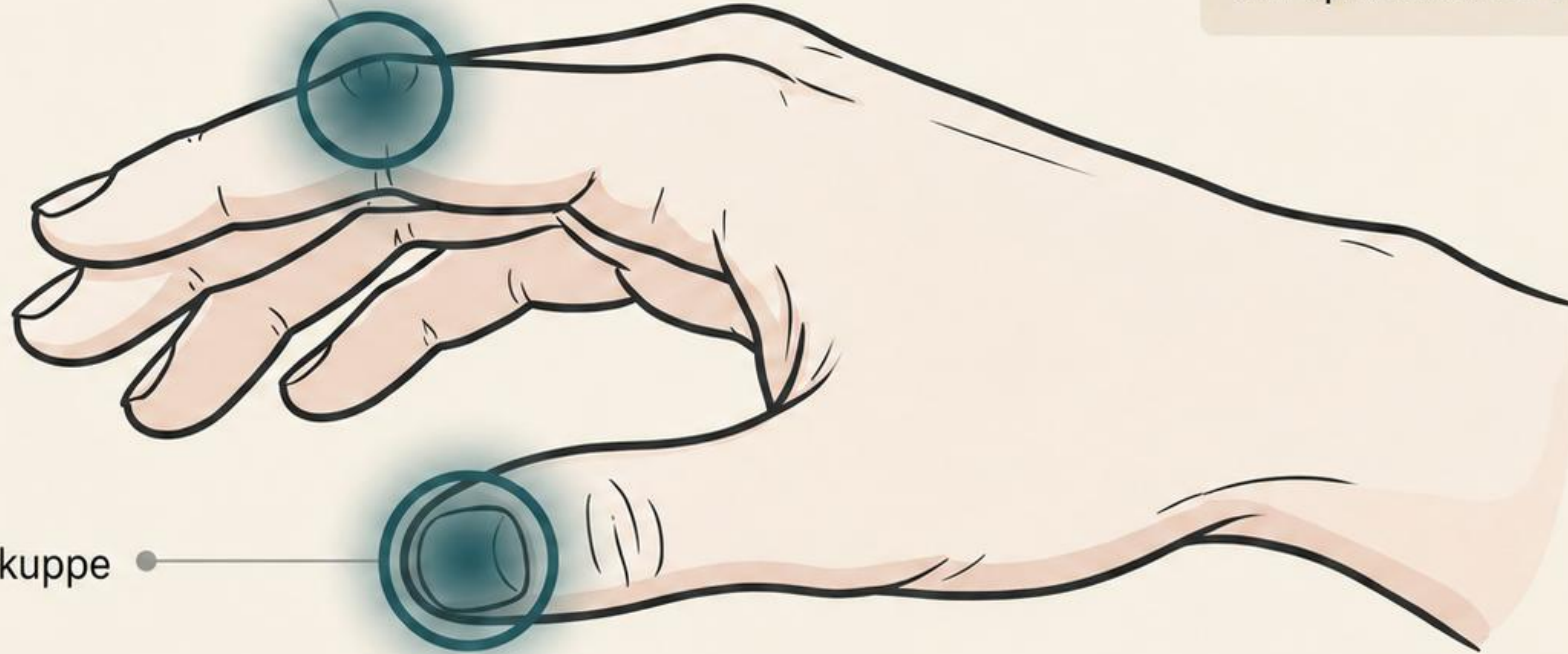
Das autonome Nervensystem anhand seiner großen podalen Orientierungspunkte verstehen



Die Präzision der therapeutischen Geste

Proximales Interphalangealgelenk
des Zeigefingers

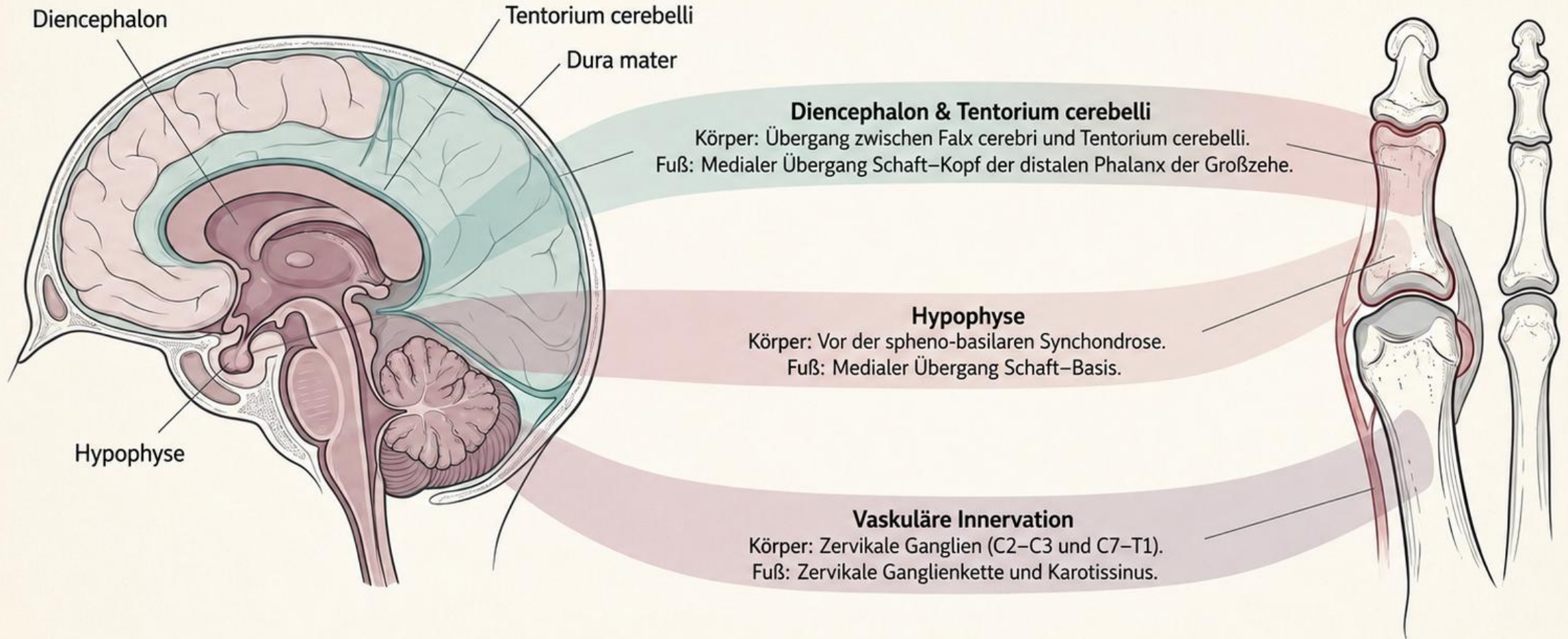
Daumenkuppe



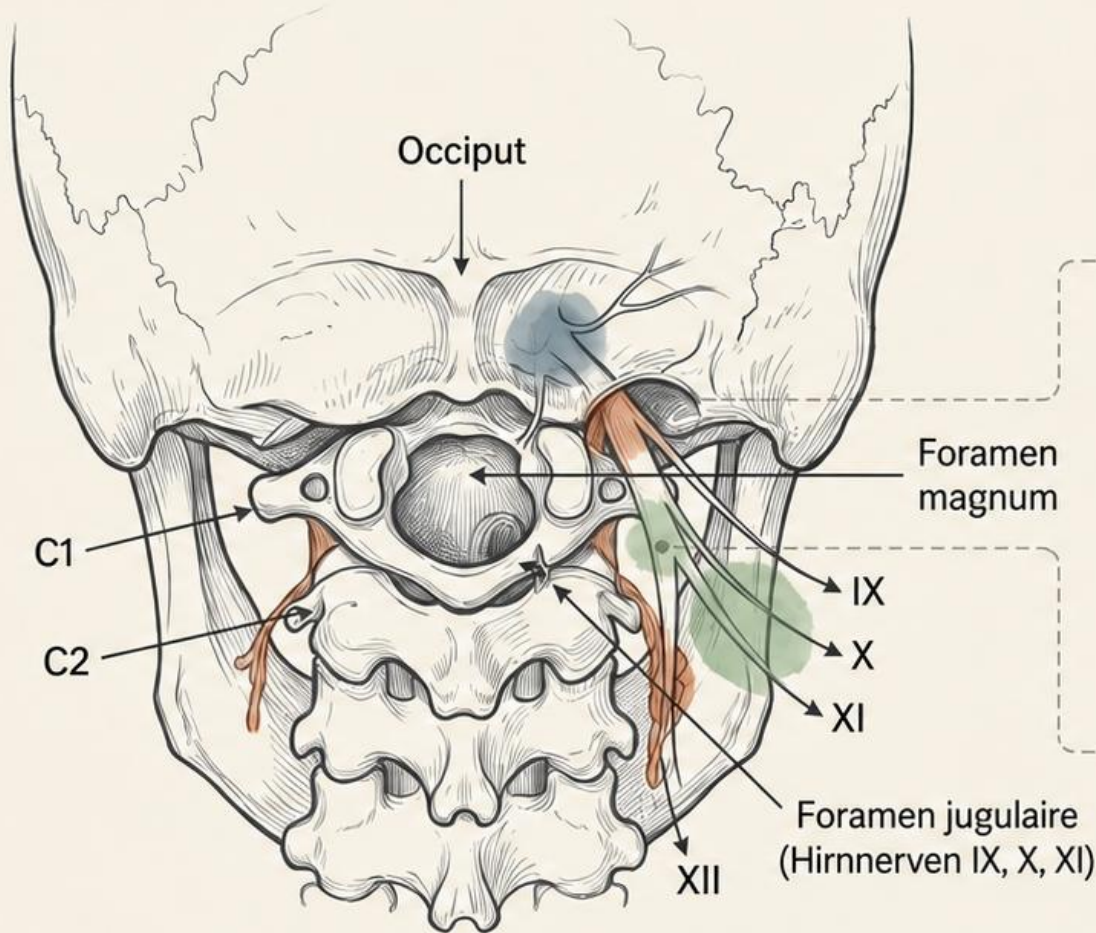
Ein ausschließlich manueller Ansatz,
ohne Zusatz von Öl oder Creme,
beruhend auf der Präzision
der epikritischen Druckausübung.

Kraftvoller Druck und Triturieren sind kontraindiziert. Je stärker der Druck ist, desto schwieriger wird die Wahrnehmung der knöchernen Orientierungspunkte und der Reflexzonen.

ROP-Korrespondenz: Diencephalon & Dura mater



Klinischer Fokus: Die obere Etage



Zielstrukturen:

- Kraniozervikaler Übergang (Occiput–C1–C2) und Foramen magnum.
- Foramen jugulare (Durchtritt der Hirnnerven IX, X, XI).
- Nervus trigeminus (V) und Nervus hypoglossus (XII).

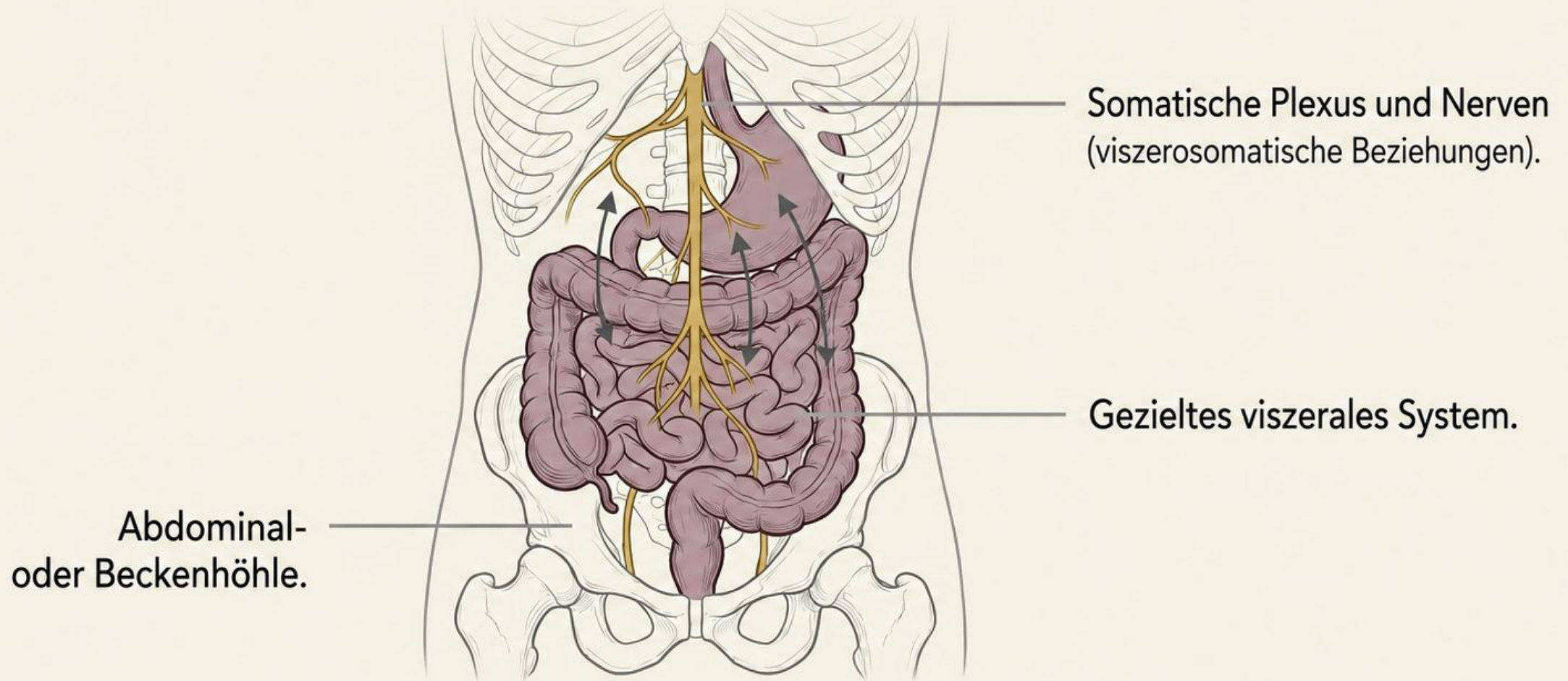
Schlüsseltechniken:

- Rebalancierung der Synchondrosis sphenobasilaris (SSB) - S2.
- Kompression des 4. Ventrikels.

Therapeutisches Ziel: Den Vagusnerv erneut stimulieren, um die « Neurozeption von Sicherheit » zu etablieren und die gesamte autonome Kaskade zu regulieren.

Ziel II : Lokoregionales Syndrom

Behandlung der mit der symptomatischen Region verbundenen Schleifen.



Ziel ist es, die lokalen Fixationen der betroffenen Höhle zu lösen, um die Gewebemobilität wiederherzustellen und die durch die Dysfunktion aufrechterhaltene neurovegetative Schleife zu unterbrechen.

Vaskularisation der kleinen Kurvatur

Truncus coeliacus
(Th12)

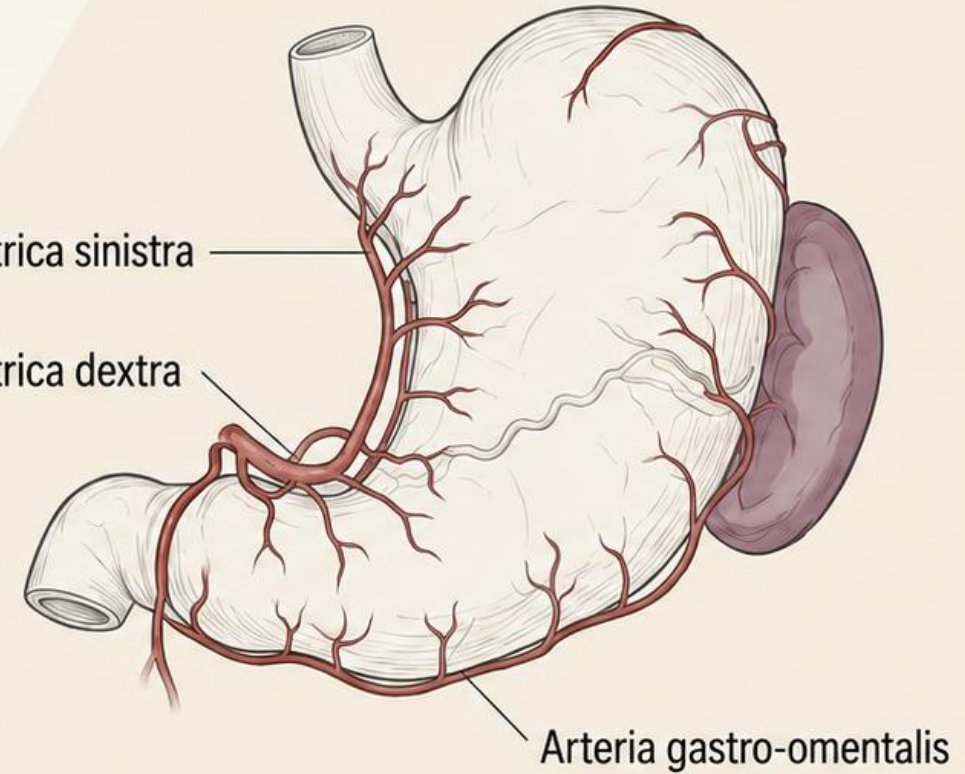


Arteria splenica,
Arteria gastrica sinistra,
Arteria gastrica dextra.

Arteria gastrica sinistra

Arteria gastrica dextra

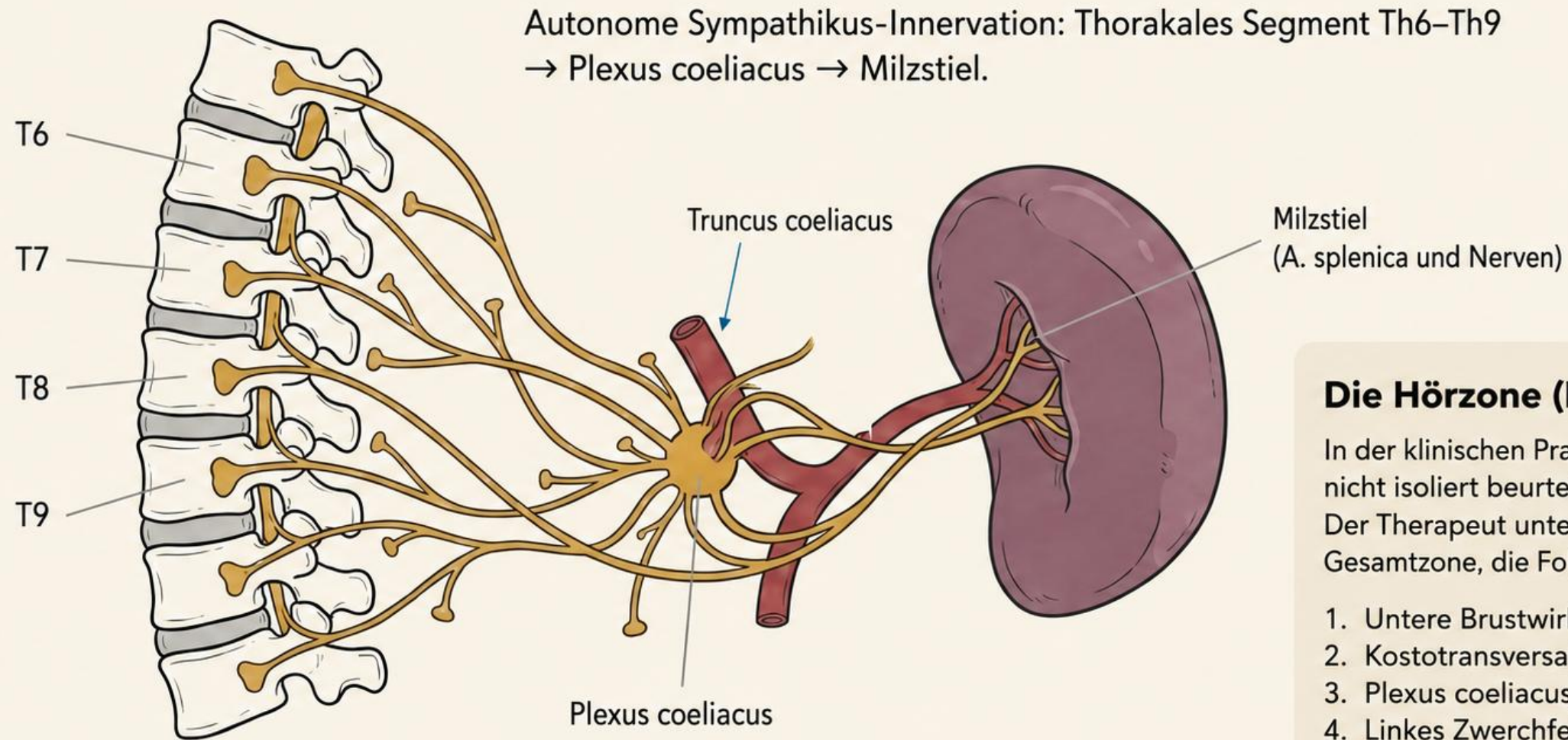
Arteria gastro-omentalis



Praktische Relevanz in ROP

Die kleine Kurvatur erfordert vorrangige Aufmerksamkeit. Sie liegt tief und ist eng an die Wirbelsäule (Th10–L1) angelegt; sie weist eine reiche Gefäßversorgung und parasympathische Innervation auf. Sie ist der bevorzugte Ort mechanischer Fixationen und gastrischer Ulzerationen.

Innervation und « Hörzone » ROP



Die Hörzone (ROP)

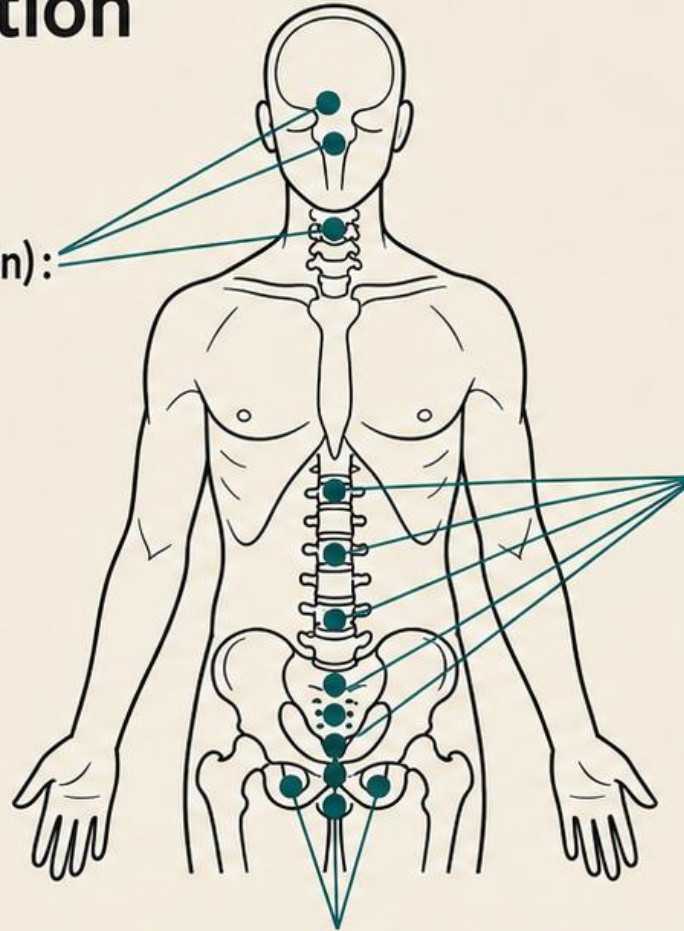
In der klinischen Praxis wird die Milz nicht isoliert beurteilt. Der Therapeut untersucht eine Gesamtzone, die Folgendes umfasst:

1. Untere Brustwirbel,
2. Kostotransversalgelenke,
3. Plexus coeliacus,
4. Linkes Zwerchfell,
5. Milzstiel

Der Therapeutische Ansatz ROP: Kartierung der Intervention

Schädel-Kreuzbein-Achse (Limbische Regulation):

- Spheno-basilaren Synchondrose.
- Gehirnstamm und Hypothalamus.
- **Indikation:** Enuresis, emotionale Dominanz, Ängste.



Neuro-vegetative Achse (Innervation):

- Sympathisch: Wirbel Th11 bis L2.
- Parasympathisch: Kreuzbein S2–S4 und Steißbein (Coccyx).
- **Indikation:** Wiederherstellung des neurologischen Gleichgewichts von Füllung/Bewegung.

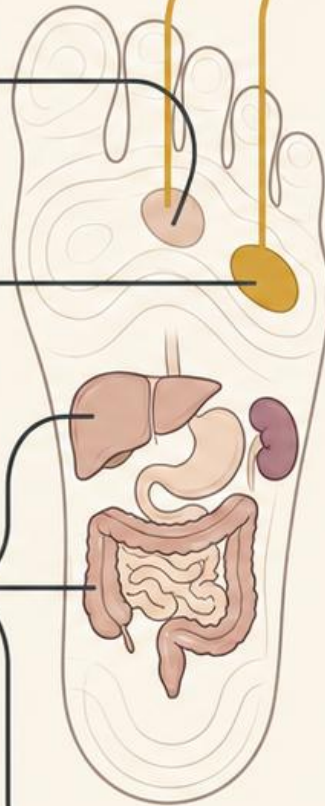
Biomechanische Achse (Beckenstruktur):

- Schambeinfuge und Obturatorforamina.
- Zentraler Faserkern des Perineums und Pudendus-Plexus.
- **Indikation:** Neuausgleich der Spannung der Urogenitalfaszien (UFE) und Entlastung der Pubovesikalbänder.

Der ROP-Ansatz: Kartografie der Fußzonen

Allgemeines Adaptationssyndrom

- **Parasympathikus des Beckens:** Sakrales Rückenmark S2-S4 (Wirbelebene L1-L2).
- **Sympathikus:** Kostotransversalgelenke T10-L2, lumbosakrale Ganglienkette.
- **Zielorgane:** Leber, Darm, Nieren (bei chronischer Zystitis).



Loco-regionäres Syndrom

- **Pubovesikale Bänder:** Hinterer Rand des medialen Malleolus.
- **Trigonum / Prostata:** Grube an der posteromedialen Fläche des Kalkaneus (über die Rinne des zentralen Faserkerns).
- **Äußerer Spinkter / Urethra:** Unterer Rand des Kalkaneus, vor dem Steißbein.



Limbisches System

- **Emotionales Gleichgewicht:** Gleichzeitiges Zuhören und Induzieren — ein Daumen auf der Reflexzone der Blase, der andere auf dem limbischen Gehirn.



Podale Kartographie: Reflexzonen

Allgemeines Adaptationssyndrom

- Wirbelsäule und kostotransversale Gelenke (sympathische Ganglienreihe Th6–Th9).
- Plexus coeliacus. ○

Loco-regionales Syndrom

- Zugehörige Organe: Magen, Pankreas, linke Niere, Wurzel des Mesokolons.
- Milzzone: Lokalisiert an der Milzflexur des Kolons (medial und kranial des Processus styloideus des linken 5. Mittelfußknochens), unter der Zwerchfellkuppel.
- Leber: Bearbeitung des linken Leberlappens und der gesamten Leber zur Verbesserung der Zirkulation in der Vena splenica.

ROP-Ergänzung

- Balance zwischen limbischem Gehirn und Milz: Hör-/Induktionstechnik (ein Daumen auf der Milz, der andere auf dem limbischen Gehirn).

